

Abridged Version

Kilde: Gammelgaard (2010)

Forelæsning: W05L1

1. Bruddet med den eksakte videnskab

s. 546–550

De humane videnskaber har traditionelt været under pres fra de eksakte naturvidenskaber for at levere faste, observerbare kendsgerninger. Klassisk psykologi søger objektive data, der kan testes af enhver under de samme betingelser. Men Gammelgaard påpeger, at dette krav er ødelæggende for psykoanalysen.

I psykoanalysen undersøger man det ubevidste og det decentrerede subjekt. Det ubevidste er per definition ikke en genstand, der bare kan vejes eller observeres passivt fra sidelinjen. Den helt store forskel er, at i psykoanalysen er det kliniske møde samtidig selve forskningslaboratoriet.

Når analytikeren lytter til patienten, kan man ikke adskille ren iagttagelse fra teoretisk tolkning. Derfor må psykoanalysen have sin helt egen definition af, hvad 'empiri' er. For at indkredse denne empiri benytter Gammelgaard fire kriterier fra filosofen Paul Ricoeur.

Kort sagt:

- Klassisk videnskab kræver fuldstændig adskillelse mellem observation og teori.
- I psykoanalysen er behandling og forskning én og samme proces.
- Psykoanalysen afviser ikke empiri, men definerer den fundamentalt anderledes.

“Psykoanalysen har sin egen empiri, hvad angår såvel behandling som forskning, og den har som sagt det særkende, at behandling og forskning til en vis grad falder sammen.”

s. 548

2. Det første kriterium: Tale-kuren

s. 550–552

Det første af Ricoeurs kriterier handler om grænsen for, hvad der overhovedet kan betragtes som materiale i analysen. Psykoanalysen har fra starten haft karakter af en 'tale-kur'.

Dette betyder, at psykoanalysens empiri strengt taget er begrænset til det, som analysanden kan sige i ord. Gammelgaard påpeger, at konkret adfærd – som at en patient skælver, udebliver fra en aftale eller vasker hænder tvangsmæssigt – ikke i sig selv tæller som kliniske kendsgerninger i analytisk forstand.

Adfærd bliver først til psykoanalytisk data, når den sættes ind i en talende kontekst, hvor patienten reflekterer over sine handlinger. Det er i sprogets brudflader, tøven og associationer, at analytikeren kan begynde at spore de ubevidste konflikter.

Kort sagt:

- Ren fysisk adfærd eller fysiologiske reaktioner er ikke direkte psykoanalytisk empiri.
- Data opstår udelukkende gennem patientens tale i det analytiske rum.
- Begrænsningen til sproget skaber et specifikt fokus på meningsdannelse frem for mekanik.

“Vi gør ikke psykoanalysen mere videnskabelig ved at henvise til konkrete udvekslinger, der foregår som objektive kendsgerninger, vi kan gøre til udgangspunkt for vores videnskabelige teoretiseringer.”

s. 550

3. Det andet kriterium: Intentionalitet og overføring

s. 552–558

Ricoeurs andet kriterium omhandler ‘henvendelsen’ eller intentionaliteten. I den analytiske situation er det, patienten siger, ikke bare fremlæggelse af information. Det er sagt med et formål, og det er altid henvendt til en specifik anden person – analytikeren.

Dette fører frem til psykoanalysens vigtigste værktøj: overføringen. Overføring sker, når patientens ubevidste, gamle konfliktmønstre ubevidst rettes mod analytikeren her og nu. Patienten agerer sin fortid ud i nutiden.

Overføringen er ikke blot en teknisk detalje; det er et epistemologisk erkendelsesmiddel. Gammelgaard beskriver det som en form for ‘kunstig sygdom’ eller et laboratorium. I stedet for at gætte på patientens barndom, kan analytikeren observere neurosen udspille sig direkte i rummet gennem patientens henvendelse.

Kort sagt:

- Tale er aldrig neutral; den rummer et ubevidst formål (intentionalitet).
- Overføring fungerer som et kunstigt laboratorium for det ubevidste i klinikken.
- Analytikeren observerer ikke fortiden, men hvordan fortiden gentages i nutiden.

“Overføring er ikke blot et stykke analytisk teknik, men et erkendelsesmæssigt kriterium for de slutninger, vi drager.”

s. 558

4. Det tredje kriterium: Psykisk realitet

s. 558–562

Det tredje kriterium adskiller afgørende psykoanalysen fra historieforskning. Det handler om den ‘psykiske realitet’. Gammelgaard påpeger, at analytikeren arbejder med patientens indre virkelighed, som oftest står i modsætning til den materielle, ydre virkelighed.

Når en patient, ligesom i Gammelgaards case, frygter, at en diktafon er blevet ‘besmittet’ med urin og vil gøre ham syg, er dette ikke materielt sandt. Men tvangstanken er udtryk for en psykisk realitet, der er aldeles virkelig i sine konsekvenser for patienten.

For analytikeren er det underordnet, om en ubevidst fantasi (fx at være blevet straffet af sin far i barndommen) objektivt set har fundet sted. Det afgørende empiriske fundament er fantasien selv, og hvordan den virker som en styrende kraft i patientens nutidige liv.

Kort sagt:

- Psykisk realitet er patientens ubevidste fantasier og indre oplevelse.
- Materiel historisk sandhed er ofte underordnet for analysens gyldighed.
- Mennesket er til en vis grad skaber af sin egen indre virkelighed.

“Begrebet psykisk realitet, som har sin begrundelse i kliniske iagttagelser, strider ikke blot mod almindelig sund fornuft, men demonstrerer, at mennesket er skaber af sin egen indre virkelighed til en vis grad.”

s. 559

5. Det fjerde kriterium: Den fortalte historie og sandhed

s. 562–566

Det fjerde og sidste kriterium er den fortalte historie, narrativet. Analysandens symptomer udgør ofte uforståelige, afbrudte brudstykker af mening. Analytikerens job er at hjælpe patienten med at binde disse stumper sammen til en sammenhængende historie.

Men hvordan beviser man, at analytikerens fortolkning af denne historie er sand, når man ikke kan teste den i et eksperimentelt setup? Gammelgaard henviser til to ting: For det første narrativ sammenhæng – at tolkningen er konsistent og inddrager symptomets kompleksitet logisk.

For det andet trækker teksten på Freuds 'tally-argument'. En tolkning valideres endeligt af dens kurative effekt. Hvis en fortolkning 'stemmer overens' med det virkelige (tallies with reality), vil den ophæve modstanden og producere en ægte terapeutisk forandring. Sandhedsbegrebet er dermed relationelt og bundet til effekten i klinikken.

Kort sagt:

- Data skal kunne samles til en narrativ historie for at give mening.
- Sandhed bevises gennem fortællingens interne, logiske sammenhængskraft.
- Freuds tally-argument: Terapeutisk effekt beviser tolkningens gyldighed.

“Med overbevisning henvises ikke blot til et retorisk greb, men til en særlig form for forklaring, der består i at skabe en sammenhængende fortælling, der er konsistent og modsigelsesfri.”

s. 566